

Etablissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI

Fausse-route / Obstruction des voies aériennes

Conduite à tenir devant suspicion de fausse-route alimentaire ou obstruction brutale des voies aériennes.

Indications

- Toux brutale lors repas/boisson ou soins de bouche.
- Gêne respiratoire, voix modifiée, hypersalivation.
- Obstruction complète : impossibilité de parler, tousser ou respirer.

Vérifications préalables

- Évaluer si la toux est efficace ou inefficace.
- Installer assis ou penché en avant si possible.
- Ne pas donner à boire ou manger pendant l'épisode.
- Alerter un collègue et préparer appel secours si aggravation.

Ne pas appliquer ce protocole

- Ne pas mettre les doigts dans la bouche à l'aveugle.
- Ne pas allonger un résident qui respire difficilement.
- Ne pas retarder les gestes de désobstruction si obstruction complète.
- Ne pas reprendre l'alimentation sans réévaluation après épisode sévère.

Conduite à tenir

- Toux efficace : encourager à tousser, surveiller et alerter IDE/médecin.
- Obstruction complète : 5 claques dorsales puis 5 compressions abdominales (manoeuvre de Heimlich) si formé.
- Alternier jusqu'à expulsion ou perte de connaissance.
- Si perte de connaissance : alerter 15 et débiter RCP/DAE si absence de respiration normale.

Surveillance et traçabilité

- Tracer heure, aliment/contexte, signes respiratoires et gestes réalisés.
- Surveiller toux persistante, fièvre, désaturation, gêne respiratoire secondaire.
- Informer médecin/IDE pour réévaluation du risque de fausse-route.

Alerte immédiate

- Appel 15 immédiat si obstruction complète, cyanose, détresse, perte de connaissance ou désaturation persistante.
- Appel médical rapide après fausse-route significative même si amélioration.

Mention de sécurité

La toux efficace doit être respectée. Obstruction complète = urgence vitale, gestes de désobstruction sans délai.

Fait à :

Le : / /

Signature :